

pidevalt tõusnud, igal aastal lisandub u 5% inimesi, kellel on vaimse tervise või intellektihäire. Eestis on ametlikult pea 50 000 psüühilise erivajadusega inimest ja kindlasti on neidki, kes pole oma hädadega veel arsti juurde jõudnud. Muidugi ei vaja kõik neist erihoolekandeteenuseid, sest piisavat abi ja

tuge saadakse ravimitest, teraapiast ja omastelt. Kui aga tekib vajadus teenuse järele, siis pole selle pärast kellelgi vaja piinlikkust tunda. Teenused peavad aitama parandada inimese toimetulekut ja rahulolu, arendama ja säilitama tema oskusi ja leevendama perede hoolduskoormust. **S**

Viidatud allikad

Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurme, Ü.-K. (2017). Pikaajalise hoolduse deinstitutionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Analüüsi aruanne. Poliitikauuringute keskus Praxis. <http://www.praxis.ee/tood/di/> (04.05.3018).

Ibrus, K. (2018). Liikumisvõimetu IT-spetsialist: Eesti oleks tõeliselt e-riik, kui ka mina saaksin töötada. Eesti Päevaleht 12.02.18.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudel kaheksas omavalitsuses



Katrin Tsuiman

nõunik, Sotsiaalkindlustusamet

Aastail 2016–2017 töötati sotsiaalministeeriumi juhtimisel ja teenuse disaini metoodika abil välja isikukeskne teenusmudel psüühikahäiretega inimestele abimeetmete pakkumiseks. Mudeli väljatöötamisel avaldasid psüühikahäirega inimesed ja nende lähedased arvamust, et kõige paindlikum ja isikukeskem oleks selline lahendus, mille puhul abimeetmeid korraldab kohalik omavalitsus. Omavalitsus on oma piirkonna inimestele kõige lähemal ning saab kiiresti ja paindlikult reageerida nende vajadustele. Ka suudab omavalitsus kaasata kogukonna ressursse.

Alates 2017. aasta maist on Sotsiaal-

kindlustusamet Euroopa Sotsiaalfondi toellu viinud projekti „Isikukeskne erihoolekande teenusmudel kohaliku omavalitsuse korralduse baasil” koos kaheksa omavalitsusega, kelleks on Haapsalu, Keila, Võhma ja Tallinna linn ning Jõhvi, Märjamaa, Otepää ja Vändra vald. Iga omavalitsus osutab projekti ajal abi vähemalt viiele psüühikahäirega inimesele.

Uue teenusmudeli kohaselt vastutab psüühikahäirega inimeste erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste sisuliste tegevuste korralduse ja kättesaadavuse eest kohalik omavalitsus. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab inimeste toetus- ja

abivajadust toimetulekuks ja elukvaliteedi säilitamiseks olulistes eluvaldkondades (sotsiaalsed suhted, füüsiline ja vaimne tervis, elukeskkond, hõive, vaba aeg ja igapäevaeluga toimetulek). Abimeetmeid pakutakse just selles valdkonnas, kus inimene seda vajab. Ehk siis inimese vajadustest lähtudes komplekteeritakse tarvilikud tegevused – kogu teenuspakett.

Kui praeguses erihoolekandesüsteemis räägime erinevatest teenustest, siis isikukeskses teenusmudelil koosneb erihoolekandeteenus mitmest komponendist, mis katavad ära inimese abivajaduse. Sealjuures on rahastus samuti seotud inimese abivajadustega, mitte konkreetse teenuskoha kuupõhise maksumusega.

Projektis osalejate positiivsele tagasisidele ja kogemustele tuginedes võib öelda, et omavalitsustel on olemas valmisolek korraldada ja pakkuda psüühikahäirega inimestele vajalikku abi. Omavalitsuste sotsiaaltöötajate hinnangul pani isikukeskne teenusmudel neid mõtlema lähtudes inimeste vajadustest ja mitte olemasolevatest teenustest. Inimesele ja tema perele on võimalik kohe korraldada toimetulekuks hädavajalikku abi ja seejärel pakkuda tuge, et saaksid kooskõlastatult ellu viidud kõik eri valdkondade tegevused, mis on osaks inimese tegevusplaanist.

Katse olulisemad tulemused

- Omavalitsus saab uut mudelit kasutades inimese vajadustest tervikpildi. Hindamisinstrument aitab hinnata toetusvajaduse ulatust eri eluvaldkondades.
- Mudeli rakendamine parandab koostööd teenuseosutajate ja kohalike omavalitsuste vahel.
- Mudeli põhimõtted soodustavad tööd perega, kellele on tagatud personaalne tugiisik, vajadusel pakutakse tuge kohe.

See on oluline, sest sageli on omastel kõige olulisem roll psüühikahäirega inimese toimetuleku tagamisel.

- Psüühikahäirega inimene saab hakata kiiremini kasutama vaimse tervise valdkonna teenuskomponente, sest info liigub operatiivsemalt ja ta ei pea minema teenuste saamiseks teise süsteemi.
- Omavalitsus ja teenuste osutajad lähtuvad inimese toetusvajadusest, mitte ainult oma teenustest.
- Teenuskomponentide hinnad ei erine oluliselt ei regiooniti ega ka mitte omavalitsuse suuruse ja võimekuse järgi.
- Inimesele vahetult teenuseosutamisega seotud kogukulud jäid madalamaks, kui on praegu erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste maksimaalne maksumus.
- Igal inimesel kujuneb isiklik ja erinev eelarvesumma, mis vastab tema kasutatud teenuskomponentidele ja nende mahule. Nt intellektihäirega kliendi toetusmaht ja isiklik eelarve on suurem kui psüühikahäirega kliendil. Mõlemal sihtrühmal on kuue kuu jooksul kasutatud isiklikud eelarved olnud keskmiselt 400–1000 eurot.
- Hindamisvahendiga kindlaks määratud toetusvajaduse aste, teenusekomponentide maht ja isikliku eelarve seos on selgelt nähtav enesehooldustoimingute valdkonnas.

Projektist saame juba ka järeldada, et teenusmudeli laiem rakendamine nõuab omavalitsuste põhjalikumat ettevalmistust ja võimestamist, nende pädevust on vaja suurendada, et paremini märgataks ja kasutataks kogukonna ressursse. Täiendavat tööjõudu on vaja juhtumikorralduseks ning kindlasti tuleb koostada juhendmaterjale uue teenusmudeli põhimõtete selgitamiseks. Mudelit juba katsetanud omavali-

tsused suudavad ja ka soovivad jätkata isikukeskse teenusmodeli rakendamist. Sotsiaalkindlustusamet aga tahab jätkata teenusmodeli katsetamist. Eesmärk on, et toimetulekuks vajalikud abimeetmed jõuaksid inimestele võimalikult lähedale ja asja korraldaksid omavalitsused ise.

Isikukeskset ja teenuskomponentidel põhinevat abikorraldust esmatasandil saab rakendada kõigile toimetulekuabi vajavatele hoolekande sihtrühmadele, mitte ainult psüühikahäirega inimestele. Selline teenusmudel võibki olla üheks võimalikuks hoolekande arenguteeks. **S**

Näide isikukeskse teenusmodeliga osutatud abist

60aastane sügava liitpuudega Mari on kogu oma elu elanud kodus koos vanematega. Tal on diagnoositud intellektipuu, noorena jäi ta lastehalvatuse tagajärjel ratastooli, ka seda kasutades ei ole ta võimeline ise liikuma. Pärast seda, kui ema asus elama hooldekodusse, jäi Mari koju koos 86aastase isaga. Ka isal on terviseprobleeme ja ta ei ole võimeline tüdrit üksi hooldama. Rehabilitatsiooniplaani koostajad soovitasid Marile ööpäevaringset erihooldusteenust. Pilootprojektis hindas kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja Mari toetus- ja kõrvalabi vajadust eri valdkondades. Kõige suurem abivajadus ilmnis igapäevaelu valdkonnas: enesehooldusel jt toimingutes. Kohalik omavalitsus korraldas isikukeskse teenusmodeli alusel Marile ja tema isale mitmesugused tegevused, mille toel sai Mari jätkata elamist oma kodus.

- Vajalikku baastoetust pakub valla hoolekandekeskus.
- Personaalset tuge ja juhendamist pakuvad hoolekandekeskuse tegevusjuhendaja ja naaber, kes on vormistatud

koduhooldustöötajaks. Toetus hõlmab abi liikumisel, söömisel ja söögitegemisel, enese eest hoolitsemisel ja majapidamistoimingutes. Kasutatakse ka valmis toidu koju tellimist ja kogukonnasauna teenust.

- Tegevusjuhendaja aitab järgida ravi- ja taastusplaani, annab tervisealast nõu ning hoolitseb, et Mari jõuaks arsti juurde.
- Koduhooldustöötaja hoolitseb, et Mari saaks kasutada KOVi transporditeenust.
- Hoolekandekeskus viis HAMET metoodika alusel läbi töövõime hindamise ja võimaldas Maril töötada talle kohandatud keskkonnas, edaspidi avanes võimalus teha võimekohast tööd pikaajalise kaitstud töö teenuse raames.
- Hoolekandekeskuses saab Mari tegevusjuhendajate toel tegeleda spordi ja liikumisega ning osaleda huvitegevuses.

Teenuskomponentide kogukulu ei ületa liitpuudega isikule mõeldud ööpäevaringse erihooldusteenuse maksumust.

Omaloodud töökohal teistele toeks

2016. aasta märtsis, kui oli teada, et Koluvere hooldekodus üks osakond suletakse, asutasid senised tegevusjuhendajad Kristel Jammer ja Milvi Elias ning veidi hiljem liitunud Maire Gilden ja Laivi Kaskla MTÜ Lemme, et aidata vaimupuudega inimestel eluga toime tulla.

Koluvere hooldekodu ootas ees järkjärguline likvideerimine, tegevusjuhendajaid aga töötu põli või Soomest koristajakoha otsimine. Kõik hoolealused ei tahtnud aastakümnetega koduseks saanud elukohta muuta, sest Koluveres ollakse nendega juba harjunud, neil on seal sõbrad ja tuttavad, oma seene- ja marjakohad. Koluveres elavad nad nõukogudeaegsetes kortermajades. Väikesed peremajad, mida riik ümberasustavatele psüühilise erivajadusega inimestele mitmetes suuremates kohtades ehitab, on küll ilusamad ja mugavamad, kuid harjumuspärane keskkond ja kogukonna toetus on mõnikord sellest olulisemad.

Koluveres leidsid hakkajad naised lahenduse, mis vastab hästi kohalikele vajadustele ja võimalustele: MTÜ Lemme on nüüd osa Koluvere Kodust ning kannab hoolt 16 inimese eest. Läänemaal on see suurim oma-taoline ettevõtmine. MTÜ tegevust rahastab Sotsiaalkindlustusamet ja neile kuulub hooldekodu endine päevakeskus.

Lidia, Erika, Grete, Merike, Lea jt hoolealused, nende seas ka kaks abielupaari, on seda võrd iseseisvad, et saavad üksi või mitmekesi oma väikestes korterites elatud, kuid igapäevastes asjatoimetustes vajavad nad abi. Osa MTÜ kliente elab riigile kuuluvates korterites, mille eest tuleb kuus maksta u 10 eurot.

Inimesed peavad hakkama saama u 300 euroga kuus. Suvel on lihtsam, sest paljudel on oma aiamaa. Tugiisik peab jälgima ravimite võtmist ja seda, et kõik arved oleksid makstud. Rahaga õpetatakse toime tulema ka neid, kelle meelest 90 senti on rohkem 1 euro. Suureks kiusatuseks on MTÜ klientidele kaubakataloogid ja nende abitust on ära kasutanud

telefonimüüjad. Et raha kohe otsa ei saaks, on hoolealuste pangakaardid tugiisikute käes. Vahel tuleb aidata arsti juures käia, soodsa hinnaga riideid osta ja toitu teha. Koos hoitakse ka korterid korras, ise ei tulda ehk koristamise peale, koos toetajaga tehakse kodutöid aga rõõmuga. Üksi jääks inimesed hätta nt nii kiirabi kui ka politsei kutsumisel.

Tugiisik peab seega olema valmis 24 tundi ööpäevas. Teha tuleb kõike ja silmapilk: telefoni tuli sõnum, aita lugeda; lukk läks katki, ma ei saa jopet seljast ära; telekanalid on kadunud, ole hea, pane tagasi; sõber suri ära, lohuta mind... Igal hommikul tulevad hoolealused oma soovidega MTÜ kontorit läbi. Uusi oskusi õpivad nad aeglaselt. Pudrukeetmise saab selgeks kuuga, kana küpsetamine on juba kõrgem matemaatika. Meelelahutuseks on televiisor, kepikõnd, seenemets jms.

Osa MTÜ kliente teeb ka tööd: nad pakivad patsikumme ja helkureid, koovad kaltsuvaipu. Kududa saab oma rõõmuks ka päevakeskuses. Sobivat tegevust otsivad tugiisikud neile pidevalt, muidu ei saaks eluga hakkama. On käidud rabas kände korjamas ja plaanis on minna metsa istutama. Seal peab tugiisik kaasas olema, sest tööandjad pelgavad teistmoodi inimesi – ei tea, kuidas nendega olla ja kardavad, et äkki juhtub midagi.

„Pole nad teistmoodi midagi. Nad on inimesed nagu meie. Või mis üldse on teistmoodi?! Nemad võivad ütelda, et hoopis meie oleme teistmoodi,“ leiab Kristel Jammer.

MTÜ naiste palk on sellise töö eest üle miinimumi, kuid tükk maad alla keskmise. Ometi tulevad nad rõõmuga tööle, sest nii rõõmsaid ja vahetuid inimesi kui nende hoolealused kohtab harva. Kunagi ei pea nuputama, mida nad tegelikult mõtlevad: mida mõtlevad, seda ka ütlevad. Naistepäevaks tegid mehed neile küpsisetordi: kuus pakki küpsiseid ja omakeedetud moos vahel.

Refereering Kaie Ilvese artilist „Pangakaart ülemuse käes, terve kataloogitais asju puudu”, mis ilmus tänavu 17. märtsil ajalehes Lääne Elu.